

Maintenant, deuxième grand réseau, tout le système digestif. Ce sera le système vitelin. Quel est le grand réceptacle ? C'est notre foie. Je vous rappelle que le foie est une rencontre d'une combinaison de deux tissus. Un tissu mésodermique et un tissu endodermique. J'ai mon tube endodermique qui est comme ceci. J'ai l'intestin supérieur, moyen et inférieur. La jonction entre mon intestin supérieur et mon intestin moyen, d'ici, va émerger ce qu'on appelle le foie. Ce foie est un foie sous forme d'un champ d'aspiration. Ce n'est qu'un nom subtil du tissu digestif. 20 vitelines, structure mésodermique pour donner mon foie. La céphalisation entraîne la cardianisation qui entraîne la diaphragmatisation qui va entraîner le côté de congestion hépatique sur un plan mésodermique, donc par l'intégration viteline. J'ai le mouvement de céphalisation qui va entraîner le mouvement de cardialisation qui va entraîner le mouvement de diaphragmatisation. Et qui va entraîner finalement, avec mon système vitelin, une phase de congestion ici, sous le diaphragme. Et cette zone de congestion, c'est à la base ce qu'on va appeler le développement mésodermique du foie. Il ne reçoit aucune information ombilicale au départ. Il est informé par les produits de désassimilation venant du cerveau, venant du tronc inférieur et venant de la vésicule viteline. Donc, sa première impulsion, c'est une zone où il reçoit la toxicité. Le foie est un organe qui, dans sa fonction, a un rôle de recevoir la toxicité et de la transformer. C'est la première impulsion qu'il reçoit. Après, il aura une impulsion régénératrice plus tard. J'ai ma veine viteline en orange droite, ma veine viteline gauche. J'ai déjà une petite anastomose qui s'est faite entre les deux. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le cordon hépatique venant de l'endoderme. Entre mes deux veines vitelines, gauche et droite, ça va former tout un réseau qui vient se congestiver. Qui vient se gestionner, qui vient se former ici. Et puis, tout ce réseau va commencer à s'organiser pour former le conduit veineux. Pour former plus tard, ici, ce qu'on va appeler la veine gastrique, la veine

gastroépiploïque. Et surtout, une zone importante qui est ma veine porte. Un autre niveau, ici, la veine ombilicale. Une partie sera intégrée, mais une autre partie va disparaître. C'est tout un réseau de systèmes vitelins qui va se rencontrer pour former une boule. Un réseau vasculaire. Un réseau vasculaire très spécifique. Donc, regardez un peu tout ce réseau, comment ça se développe, qui vient du réseau vitelin. Qui est un système de drainage. Ce développement se déroule sous le septum transversum. Et la veine viteline qui est située sous ce septum peut être divisée finalement en trois sections. Une section suprahépatique, qui va former finalement le conduit hépatique pour former la veine hépatique. Une section hépatique. Et une section infrahépatique. Un, deux, trois. La section suprahépatique, qui va former finalement le conduit hépatique pour former la veine hépatique. La section suprahépatique. La veine viteline droite devient la veine hépatique. Il s'agit de la région de l'écoulement vers le cœur. Un autre dérivé de cette partie viteline est la partie supérieure de la veine cave inférieure. Alors, il y a encore des régressions qui vont se faire. La veine ombilicale gauche, elle, elle régresse. Mais la veine ombilicale droite, une partie va rester. C'est là où il va avoir ce lien, tu vois, qui va se faire pour former les sinusoides hépatiques. Avec ma veine viteline ombilicale ici. Et on voit que la veine ombilicale gauche va faire ce lien. Et petit à petit, il disparaîtra après. Dans sa partie supérieure. Mais c'est surtout ce canal, ce fameux canal d'Arantius qui sera formé avec mon trompe-porte. La région infrahépatique, la veine viteline gauche va régresser. Mais pas avant d'avoir développé une anastomose avec la veine viteline droite. Ça va avoir un changement de drainage dans le sang. Où il va passer du côté gauche des viscères abdominaux. Pour s'écouler vers la veine viteline droite. Pour créer tout ce réseau transversal qui va se développer. Donc on va avoir un switch, cette fois-ci, du côté gauche vers le côté droit. Sur le plan veineux. Qui va donner cette force de

croissance aussi à droite. Tout le sang qui vient du côté mésentérique ici. Droit. Sera drainé par le système portal. Et va surtout se retrouver dans le foie droit. Tandis que tout ce qui est inférieur. Estomac, rate et colon inférieur. Va plutôt se drainer au niveau du foie gauche. Et en fait, on peut même retrouver comme deux courants au sein même du système portal. Un qui va plutôt s'orienter vers le côté gauche. Et un plutôt vers le côté droit. Vous avez un foie digestif, métabolique. Et vous avez un foie moteur, un foie émotionnel. Tout ce qui est ici sera en rapport avec le système émotionnel pur. Estomac, rate. Tout ce qui est rêve, cauchemar, etc. Je vous rappelle, c'est des congestions qui vont se retrouver ici. Alors le tronc porte, il sera commun ici. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on constate qu'il y a un flux. Qui ne va pas se mélanger. Ou peut se mélanger. Il ne se régénère jamais sur son plan endodermique. Mais se régénère toujours sur son plan mésodermique. Donc il peut refaire des vaisseaux. Mais il ne va pas reconstruire des canaux. Parce que le foie, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de canaux biliaires intégrés avec plein de vaisseaux. Rappelez-vous toujours que le foie ne sait se régénérer que la nuit. Vous avez trois niveaux. Quand vous mangez, vous avez beaucoup de sang veineux et peu de sang artériel. Le foie ne se régénère pas. Dans les périodes entre les repas, vous avez un équilibre à peu près entre le sang artériel et le sang veineux. Le foie se régénère un peu. La nuit, quand vous dormez, vous avez beaucoup de sang artériel et peu de sang veineux. C'est pour ça qu'il est très très très bon de faire des jeûnes. Vous permettez deux choses. A le foie de se régénérer. Vous permettez également aussi à toutes les cellules de devenir plus fortes. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elles sont obligées de faire ? Elles doivent libérer une énergie venant de l'intérieur vers l'extérieur. Un rééquilibrage entre le cœur. Le foie, la rate et le système mésentérique, donc l'intestin grêle. Ça, c'est toute une unité fonctionnelle. Ça veut dire que lui, c'est un régulateur de

volume. J'augmente ou je diminue ma volémie. Je peux réinjecter de l'information. Il est capital dans le développement de l'embryon. Et il sera capital à la naissance. Ce sont des compressions osseuses, ce sont des compressions tissulaires. Mais ce sont des changements vasculaires énormes. Imaginez un peu. Tout le sang, il part ici. Congestion ici. Puis l'inverse. Il faut traiter ça sur un plan fluide, une naissance. Pas que sur un plan compressif. On voit bien tous ces réseaux vasculaires qui vont se retrouver ici. C'est ce conflit rétrohépatique. Vraiment important par rapport au retour du cœur. Le confluent subhépatique ici. Et aussi, c'est ce confluent jugulaire. Ça, c'est vraiment deux grandes clés là. Attention de ne pas surcharger le cœur sur le plan retour veineux. Il faut qu'il soit dans une bonne fonction systolique. Il ne faut jamais faire ça dans une diastole. Tu vas l'aider si c'est un foie systolique. Tu vas permettre de résorber. Donc il faut permettre de libérer la fonction faciale pour redonner la libération hépatique. N'oubliez pas de bien voir cette liaison cœur-foie-rate. Tout le mouvement de la cavité amniotique. Et on voit la vésicule viteline qui est ici, qui régresse et qui vient se déposer sur le cordon ombilical. Et il y a juste à un moment donné une ansse qui se développera. Comme on a vu la fois passée. C'était le développement dans la vésicule viteline et puis la résorption qui revient ici par rapport au cordon ombilical. Pour réintégrer l'anse intestinale à l'intérieur. Dans ce cordon ombilical, j'ai les vaisseaux en spirale dans mon pédicule embryonnaire. Et puis je vais avoir la liaison des deux. Avec le vestige vraiment du iol sac qui se mettra ici. Le tube intestinal. Le pédicule embryonnaire qui se rejoint ici. Et puis on voit ici avec l'allantoïde et tout le processus qui est ici. Donc c'est toute l'intégration qui revient ici avec cette grande cavité amniotique.